

Documentation-Driven Threat Analysis

DermaTriage Case Study

Documentation + Base Analysis

Ricostruzione DDTA del progetto DermaTriage

La documentazione di progetto occupa la parte principale della pagina. La Base Analysis viene riportata in parallelo nella colonna laterale soltanto quando esiste un significato documentale da analizzare.

Struttura del case study

Il documento segue la progressione DDTA dal contesto generale del progetto agli elementi documentali successivi. Ogni elemento viene presentato nella colonna documentale; la colonna Base Analysis mostra esclusivamente l'analisi derivabile da quel significato, senza introdurre fatti di progetto aggiuntivi.

1 Contesto generale del progetto

Documentazione DDTA

Project Problem Framing

Il problema che DermaTriage deve affrontare e' il supporto al triage precoce di casi dermatologici relativi a lesioni potenzialmente oncologiche. Il progetto parte dalle informazioni gia' disponibili sul caso per determinarne l'urgenza e una priorita' operativa di presa in carico, con l'obiettivo di favorire un instradamento specialistico tempestivo.

Base Analysis

Base Analysis

Il contesto generale definisce il problema affrontato dal progetto, ma non introduce ancora un elemento documentale strutturato da decomporre in referenti e proposizioni. La Base Analysis viene quindi applicata a partire dagli elementi DDTA successivi, quando il significato governato rende identificabili responsabilita', relazioni, condizioni o risultati analizzabili.

2 MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare, a partire dalle informazioni disponibili sul caso dermatologico, l'urgenza del caso e la relativa priorità operativa di triage.

Context

La valutazione di triage utilizza le informazioni disponibili sul caso dermatologico. La disponibilità e la tipologia delle evidenze possono variare tra i casi.

Stakeholders

Paziente.

Scope

IN: determinazione dell'urgenza del caso e della relativa priorità operativa di triage a partire dalle informazioni di caso governate dal progetto.

OUT: indicazione della destinazione specialistica; validazione o correzione medica dell'esito; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base della revisione clinica.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Domande sulla documentazione

- HIGH / MEDIUM / LOW e' una convenzione governata autonomamente o un vocabolario downstream usato coerentemente?
- I percorsi diretto e B4-integrato sono due strategie che il progetto intende preservare oppure due interfacce della realizzazione corrente?
- Il recupero di casi storici ha governance autonoma oppure e' comportamento interno della pipeline image-based?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale dell'MR.

3 DEC-MR01-01 - Triage in assenza di immagine

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

Un caso dermatologico può avere un'immagine della lesione, oppure no.

Decision

DermaTriage valuta il triage anche se manca l'immagine della lesione. In quel caso usa le informazioni sui sintomi disponibili sul caso.

Consequences

Se l'immagine manca, il triage si può comunque fare. Il percorso basato sui sintomi può usare informazioni diverse; non deve per forza dare gli stessi risultati del percorso con immagine.

Domande sulla documentazione

- Che cosa costituisce esattamente una immagine assente o non disponibile?
- Quali informazioni sintomatologiche minime devono essere disponibili?
- E' richiesta equivalenza di output fra percorso con immagine e percorso senza immagine?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

4 DEC-MR01-02 - Scala di priorit  P1-P4

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

Il triage deve indicare anche una priorit  operativa per la presa in carico del caso.

Decision

DermaTriage usa la scala P1-P4 per rappresentare la priorit  operativa di triage.

Consequences

La priorit  operativa   uno dei livelli P1, P2, P3 o P4. Le regole per assegnare il livello a un caso sono definite a parte.

Domande sulla documentazione

- Qual   la regola completa che mappa urgenza e confidence sulla P-scale?
- La soglia di confidence   un parametro configurabile o una regola governata?
- I valori temporali associati a P1-P4 sono SLA normativi, target o semplici valori documentati?
- Chi governa l'eventuale trigger e l'owner degli SLA?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non   ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verr  compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

5 DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

Se c'è un'immagine della lesione, la valutazione di triage combina più passaggi analitici prima di arrivare a una sintesi del caso.

Decision

DermaTriage realizza il percorso basato sull'immagine con una pipeline sequenziale a quattro stadi. I risultati dei primi stadi alimentano le elaborazioni successive, fino alla sintesi di triage.

Consequences

Il percorso analitico resta una sequenza di quattro stadi. Le tecnologie e i modelli dentro i singoli stadi possono cambiare o evolvere senza per forza modificare questa struttura.

Domande sulla documentazione

- E' governato il numero esatto di quattro stadi o soltanto la separazione delle funzioni analitiche?
- L'ordine degli stadi e' un commitment stabile oppure una proprieta' della realizzazione corrente?
- Quali responsabilita' appartengono alla Decision e quali restano comportamento interno dei singoli stadi?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

6 DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorità operativa

Documentazione DDTA

Decision

Parent MR

MR-01

Context

La valutazione del caso produce prima un risultato sull'urgenza, poi una priorità operativa per la presa in carico.

Decision

Nel percorso basato sull'immagine, DermaTriage tiene separata la valutazione analitica dell'urgenza dalla determinazione successiva della priorità operativa di triage.

Consequences

La priorità operativa si determina dopo la valutazione dell'urgenza, non dentro la pipeline analitica. La priorità risultante si esprime con la scala P1-P4.

Domande sulla documentazione

- La separazione e' un boundary architetturale intenzionale o soltanto la forma corrente della pipeline?
- La priorità operativa potrebbe essere prodotta direttamente dall'ultimo stadio senza violare un commitment documentato?
- Quali semantiche appartengono al boundary e quali alla futura regola operativa di mapping?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questa Decision non e' ancora stata eseguita. Questa colonna resta intenzionalmente non popolata nel presente passaggio e verra' compilata nel successivo step di analisi, senza modificare il significato documentale della Decision.

7 MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Determinare un'indicazione di destinazione specialistica per il caso dermatologico, a supporto del successivo instradamento verso l'assistenza appropriata.

Context

DermaTriage associa al risultato del processo di triage un'informazione orientata alla destinazione specialistica. La documentazione disponibile non stabilisce il vocabolario delle destinazioni, la regola di selezione né la responsabilità di assegnazione o prenotazione.

Stakeholders

–

Scope

IN: produzione di un'indicazione di destinazione specialistica per il caso.

OUT: prenotazione; assegnazione effettiva; tassonomia completa delle destinazioni; regola completa di selezione e fallback.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

STOP AT MR

Il significato macro è sufficientemente distinguibile, ma la documentazione disponibile non governa commitment ulteriori sufficienti per una decomposizione fedele. Il branch si arresta intenzionalmente a MacroRequirement.

Domande sulla documentazione

- Qual è il vocabolario governato delle destinazioni specialistiche?
- È documentata una regola di selezione della destinazione?
- Chi possiede l'assegnazione o la prenotazione effettiva?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non è ancora stata eseguita. Il successivo passaggio analitico dovrà consumare soltanto il significato qui documentato, preservando lo STOP AT MR e senza inferire regole di selezione specialistica mancanti.

8 MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire al medico di validare o correggere gli esiti prodotti da DermaTriage e rendere disponibile il risultato della revisione nel contesto del caso cui si riferisce.

Context

Gli esiti prodotti da DermaTriage possono essere sottoposti a revisione medica. Il medico può validarli o correggerli; il progetto gestisce il risultato della revisione senza includere in questa responsabilit  il successivo adattamento del sistema.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: gestione del risultato della validazione o correzione medica e sua associazione al caso o all'esito cui si riferisce.

OUT: meccanismi tecnici di scambio e autenticazione; adattamento successivo del comportamento del sistema sulla base delle correzioni raccolte.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

None

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non   ancora stata eseguita. Nel passaggio successivo dovr  essere verificato quali referenti e relazioni siano realmente derivabili dal significato documentato, senza introdurre una semantica della revisione clinica non stabilita dalla documentazione.

Domande sulla documentazione

- La revisione medica affianca o sostituisce l'esito originario?
- Quali parti dell'esito possono essere validate o corrette?
- Quali requisiti di correlazione tra revisione e caso sono realmente governati?

9 MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica

Documentazione DDTA

MacroRequirement

Intent

Consentire l'adattamento controllato del comportamento di DermaTriage utilizzando i risultati delle validazioni e correzioni mediche raccolte.

Context

Le correzioni mediche vengono utilizzate per modificare nel tempo il comportamento del sistema. L'evoluzione dei prompt e il riaddestramento del classificatore sono modalita' correnti di realizzazione di questa responsabilita' e non ne definiscono l'identita' macro.

Stakeholders

Medico.

Scope

IN: adattamento del comportamento del sistema sulla base dei risultati della revisione medica disponibili.

OUT: produzione del giudizio di validazione o correzione medica; dettagli dei singoli meccanismi di adattamento.

Assumptions / Constraints

–

dependsOn

MR-03

Domande sulla documentazione

- Quale evidenza clinica e' sufficiente per attivare l'adattamento?
- Chi autorizza l'adozione del comportamento adattato?
- Quali criteri di accettazione, rollback e reversibilita' sono governati?

Base Analysis

Base Analysis

La Base Analysis di questo MacroRequirement non e' ancora stata eseguita. Il successivo passaggio dovra' preservare la dipendenza semantica da MR-03 senza trasformarla in containment o co-ownership e senza promuovere automaticamente i meccanismi correnti di adattamento a responsabilita' macro autonome.

10 Indice di integrità' delle pagine

Regola di verifica

Ogni pagina possiede un MD5 del proprio contenuto canonico. Il calcolo esclude il valore MD5 stampato sulla pagina, gli header/footer e i metadati di impaginazione esterni al relativo blocco di contenuto. Per la pagina dell'indice, gli hash delle pagine precedenti fanno parte del contenuto controllato; il solo hash della pagina indice viene sostituito dal token canonico <SELF> durante il calcolo, evitando una dipendenza circolare.

Pag.	Contenuto	MD5 contenuto
1	Frontespizio e struttura del case study	ccabe4bed7cca4d2f68a2005e42f36e3
2	Contesto generale del progetto - Project Problem Framing	0fb76dc0491da2793823b20571e5268b
3	MR-01 - Valutazione di triage del caso dermatologico	3c912396a2040761bc527a68c3bf6205
4	DEC-MR01-01 - Triage in assenza di immagine	b50a158164de4435f5d4734d81a16d0e
5	DEC-MR01-02 - Scala di priorit� P1-P4	68f6d5a7d59e200fa4d8c5dab56b502a
6	DEC-MR01-03 - Pipeline analitica a quattro stadi	9a5e19b0746c48dbed7e76087825df98
7	DEC-MR01-04 - Separazione tra valutazione dell'urgenza e priorit� operativa	b3a101c7fe384e6a930410d43b6b1944
8	MR-02 - Indicazione della destinazione specialistica	abf9008d770509039fc7ffbd1cf1f655
9	MR-03 - Validazione e correzione medica degli esiti	589ab9dd2fc47da8ed0c64692eb2a76d
10	MR-04 - Adattamento controllato sulla base della revisione clinica	58aca712eadb3222507468f39fae50fe
11	Indice di integrit� delle pagine	b537c52d580fb67dfad87d78393790bb

Quando una pagina viene modificata intenzionalmente, cambia il suo MD5. Una variazione inattesa segnala una modifica da riesaminare prima di proseguire.